

蘇生の倫理は個人の失敗ではなくシステムの産物 — 22研究から導かれた倫理的経路モデル (EPM・ナラティブレビュー・ResuscPlus2026)

出典 Khayat Kakhki S, Daneshfar M, NamaeiQasemnia A, Yousefnezhad M, Kazemi S.
Reimagining resuscitation ethics: a narrative review and emergent ethical pathways model.
Resusc Plus. 2026;29:101323. DOI: 10.1016/j.resplu.2026.101323

掲載誌 Resuscitation Plus(2026)

原著 doi.org/10.1016/j.resplu.2026.101323(本文PDFは別途)

原題 Reimagining resuscitation ethics: a narrative review and emergent ethical pathways model



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み **変わること(着手できるもの)**

- **DNAR指示のスコープを紙で定義する**:この論文が最も繰り返し指摘するのは「DNRが胸骨圧迫だけを指すのか、気道確保・昇圧薬・除細動まで含むのかがチーム内で一致していない」という点。当院のDNAR記載様式に「心停止時のみ有効／心停止前の気管挿管・昇圧薬・ICU入室は別途判断」を明示する欄を作れば、この曖昧さは構造的に減らせる。日本救急医学会の用語統一([日本救急医学会 高齢者救急に関する用語の統一概念 — DNAR指示が有効なのは心停止時のみ、「予想された急変」とフレイル2潮流 \(JJAAM2025\)](#))と同じ方向で、当院の様式に落とすのが次の一手
- **RRS起動時に「蘇生の方針」を必ず1行確認する運用**:本レビューが描く「危機駆動型の蘇生 (crisis-driven CPR)」は、急変してから初めて方針を議論することで生まれる。RRSコール時に方針欄を必ず読む・無ければその場で確認する、という1ステップの追加は当院の既存フローに組み込みやすい
- **コード後デブリーフィングの定型化**:本レビューで一貫して有効性が語られた支援は、倫理コンサルテーションと構造化デブリーフィングの2つ。当院のICUで「蘇生後15分のホットデブリーフ (臨床＋感情の2部構成)」を看護師主導で回す形は、moral residue の蓄積を止める最も安価な介入になりうる
- **看護師を蘇生の方針決定に構造的に入れる**:テーマ4が示すのは「医師が決め看護師が従う」構図そのものが非倫理的実践の駆動因だということ。多職種カンファに看護師の発言枠を明示的に置く([看護師ファシリテーターはなぜ効かなかったか — 役割の曖昧さと縄張り \(質的研究・ICM2024\)](#)) が示すとおり、役割を曖昧にしたまま人を置くだけでは効かない

変わらないこと(この論文では動かせないもの)

- 本レビューは介入研究ではなく、効果量も推奨も提示しない。「デブリーフィングを入れれば moral distress が下がる」ことを証明した論文ではない。当院で何かを導入する根拠としては、本レビューは「問題の地図」であって「効果の証拠」ではない
- 22研究のうちイランが5件と最多で、DNR法が存在しない法域の記述が理論の骨格に強く効いている。DNARが診療録上の指示として一定の運用実績を持つ当院とは前提が違う部分がある



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 蘇生をめぐる倫理的問題は個別には十分に記述されてきた。無益なCPR、slow code、moral distress、DNR/DNARの解釈のばらつき、家族の意向による方針の上書き、法的曖昧さによる防衛的蘇生 — いずれも国際的に繰り返し報告されている。Ethicus-2 ([欧州ICUにおける終末期医療の変化 \(Ethicus-2, JAMA2019\)](#))をはじめ、地域差の大きさも既知
- **Unknown**: これらの要因が「別々の現象」ではなく「相互作用する一つの倫理システム」としてどう連動するかを説明する統合的枠組みが無かった。とくに、なぜ symbolic CPR や defensive resuscitation、moral residue が特定の条件下で再生産されるのかを、構造・関係・個人の3層をまたいで説明するモデルが存在しなかった
- **What's new**: 2020～2025年の22研究を反射的テーマ分析で統合し、7テーマを抽出。そこから創発的に **Ethical Pathways Model (EPM)** を構築した。EPMは、マクロ(法・組織文化・資源・文化宗教規範)／メソ(家族の期待・チーム階層・コミュニケーション)／ミクロ(道徳的感受性・倫理的能力・バーンアウト・個人の価値観)の3層の決定因が「ケアの相応性 (proportionality of care) = CPR/DNR決断点」に収束し、そこから **倫理的に整合した経路** と **倫理的に葛藤した経路** に分岐する、という構造を提示する。著者らは繰り返し「これは仮説生成的な解釈的枠組みであって、決定的な説明モデルではない」と留保している



全体要約

要旨

ひとことで 蘇生をめぐる倫理的問題は臨床医個人の道徳的欠陥ではなく **法・組織・階層・文化が生み出す構造的な産物** であり、22研究の統合から、その生成メカニズムを3層(マクロ・メソ・ミクロ)で説明する仮説生成的な概念モデル(EPM)が提示された。

- 4データベース(Web of Science／PubMed／Scopus／Embase)を2020年1月～2025年11月で検索し(最終検索2025年12月3日)、124件から重複79件を除いた45件をスクリーニング、最終的に **22研**

究を組み入れた

- 7つの相互に関連するテーマが生成された：(1) 無益・不適切・象徴的CPR、(2) moral distress・情緒的負担・moral residue、(3) 倫理的曖昧さと不明確な決定経路(DNR/DNAR/ToR/LR)、(4) 階層・権力と制約された看護の道徳的主体性、(5) 家族の影響・文化的宗教的規範・真実告知の実践、(6) 非倫理の実践を駆動するシステム・法・組織要因、(7) 倫理的能力・道徳的感受性・アドボカシー・倫理支援
- 22研究は中国・イラン・トルコ・パキスタン・スウェーデン・日本・イスラエル・南アフリカ・インドネシア・スペイン・スロベニア・オーストラリア・米国・韓国と地理的に広く分布し、ICU・救急外来・病院前救護・血液腫瘍病棟・混合病棟を含む
- 定量的な最大のエビデンスは Druwé 2021 (24か国288施設・救急臨床医5099人) で、**3分の2超が「不適切」と判断するCPRを頻繁に目撃**しており、それが moral distress の高さと離職意向に関連していた
- 考察では、これらの現象を生命倫理の四原則(自律・善行・無危害・正義)に対応づけている。DNR/DNARの曖昧さは自律を、無益・象徴的CPRは善行と無危害を、混雑・資源制約・緩和ケア体制の弱さは(分配的)正義を、それぞれ侵食する
- EPMは4領域(構造的決定因・関係的決定因・個人的決定因・ケアの相応性の決断点)と2経路(整合／葛藤)、および結果(陽性／陰性アウトカム)とシステムへのフィードバックループから成る
- 限界は明確に述べられている：ナラティブ(非系統的)デザインによる出版・選択バイアス、方法と文脈の異質性、質的研究の優位による一般化可能性の制約、そして **モデルが文献由来であり前向きに検証されていない** こと

詳細

1. まず前提 — 蘇生の倫理をめぐる基礎

要旨

5分で背景を掴む このレビューを読むために必要な用語を、初出で定義しておく。

生命倫理の四原則(Beauchamp & Childress): 本論文の考察が骨組みとして使う枠組み。

- **自律尊重(autonomy)**: 本人が自分の価値観に基づいて決める権利を尊重する。本人の意思が分からない・伝わっていない・上書きされると侵食される
- **善行(beneficence)**: 患者の利益になることをする
- **無危害(nonmaleficence)**: 害を与えない。無益な蘇生は「利益なく苦痛だけを延長する」ため、善行と無危害の両方に反する
- **正義(justice)**: とくに分配的正義。限られた資源(病床・人員・緩和ケア)をどう配分するか

DNR / DNAR: Do Not Resuscitate / Do Not Attempt Resuscitation。「心停止時に心肺蘇生を試みない」という指示。本レビューが繰り返し指摘するのは、この指示の**スコープ(範囲)が現場で一致していないこと** — 胸骨圧迫だけなのか、気道確保・薬剤投与・除細動まで含むのか。日本では日本救急医学会が「DNAR指示が有効なのは心停止時のみ」と用語を統一している

ToR(Termination of Resuscitation): 蘇生の中止。開始した蘇生をどの時点でやめるか。病院前では中止の権限・基準が現場に無い場合、望まれない蘇生が延々と続く

LR(Limited Resuscitation) / partial code: 「一部だけやる」蘇生。胸骨圧迫はするが挿管はしない、薬剤は使うが除細動はしない、といった部分的指示。本レビューは、これが**難しい終末期の話し合いの代替物として使われている**と指摘する

Slow code / symbolic CPR(象徴的蘇生): 意図的に強度を落とした、あるいは効果を期待していない蘇生。家族に「やった」と見せるため、法的非難を避けるため、家族の到着を待つため、方針が不明確なために行われる。演技としての蘇生(performative resuscitation)とも呼ばれる

Futility(無益性): その介入が患者に意味のある利益をもたらさないこと。倫理的には「臨床医は無益な治療を提供する義務を負わない」とされるが、本レビューが示すのは、法的リスク・組織文化・階層がその原則を現場で無効化しているという現実

代理意思決定(surrogate decision-making): 本人が判断できないとき、家族等が本人の意思を推定して決める。本レビューでは、多くの文脈でこれが「本人の推定意思」ではなく「家族自身の希望」として機能し、記載済みのDNR指示すら上書きしていた

Moral distress(道徳的苦痛・Jameton): 何が倫理的に正しいか分かっているのに、制度的障壁のためにそれを実行できないときに生じる苦痛。**Moral residue(道徳的残滓・Epstein & Hamric)** は、その苦痛が解消されずに蓄積し、侵襲的記憶・後悔・「汚された」感覚として残ったもの。反復すると**moral erosion(道徳的摩耗)** に至り、slow code や記録の歪曲、密かな治療差し控えが「普通のこ

と」になる。さらに進むと **moral disengagement(道徳的離脱)** — 自分の行為を倫理的判断の対象から外してしまう状態になる

MMAT(Mixed Methods Appraisal Tool)2018版: 質的・量的・混合の異なるデザインを同じ枠組みで質評価するためのツール。本レビューの質評価に使われた

反反射的テーマ分析(reflexive thematic analysis, Braun & Clarke): データへの馴染み→初期コード生成→候補テーマ構築→テーマの検討と精緻化→叙述的統合、という手順。分析者自身の立場がコーディングに影響することを前提とし、それを明示的に振り返る(reflexivity)ことを求める

2. 背景と目的

蘇生は現代医療のなかで特異的に複雑な倫理的空間を占める。CPRは救命のための必須介入と広く見なされる一方で、進行した疾患・予後の不確実性・関係者の期待の対立という文脈で適用されるとき、深い倫理的緊張を生む。国際文献は一貫して、CPRとDNR/DNAR指示をめぐる決定が臨床指標だけでなく、法的枠組み・組織規範・文化的価値・対人力学によっても左右されることを示してきた。その結果、患者の意向と食い違うケア、臨床医の moral distress、非有益・無益な介入の継続が生じる。

著者らが指摘する**ギャップ**は明快である。moral distress、終末期コミュニケーション、倫理的意思決定について膨大な研究がありながら、それらは**断片的**にとどまっている。既存研究は家族の関与・法的曖昧さ・臨床医の苦痛といった個々の構成要素を、相互作用する要素としてではなく**単独**で扱う傾向がある。集中治療における倫理的意思決定の枠組みはいくつか存在するが、システム・関係・個人の因子がどう相互作用して蘇生時の倫理的経路を形作るかを統合的に説明するものは無い。さらに、これらの経路が symbolic CPR、defensive resuscitation、moral residue といった現象にどう寄与するかはほとんど分かっていない。

このギャップが重要なのは、蘇生の決定が**時間的圧力のもと・階層的なチーム構造の中で・患者の価値観が十分に知られていないか十分に伝わっていない状況**で行われるからである。この急性で高リスクな環境で、看護師はしばしば倫理的葛藤の結節点に置かれる — 治療計画を実行し、明確化し、ときに異議を唱えつつ、患者の表明された、あるいは推定される意思を代弁する役割を担う。これらの力学についての一貫した概念的理解が無ければ、臨床医と医療システムは倫理的に妥協した実践、DNR/DNAR運用の不整合、そしてスタッフ(とくに看護職に不均衡に重くのしかかる)moral distress の増大に対して脆弱なままである。

目的は、多様な文化的・臨床的セッティングを横断してエビデンスを統合し、蘇生の決定を形作る多層的な倫理的力を明確化すること。著者らは重要な留保を置いている — 統合の過程で反復するパターンが浮かび上がり、それが結果として EPM の構築につながったのであって、**モデル構築は事前に設定された目的ではない**(an interpretive output of the review, not an a priori objective)。

3. 方法(Methods)

3-1. レビューデザイン

構造化ナラティブレビュー (structured narrative review) の方法論を採用。この設計を選んだ理由は、異質な実証研究を統合しつつ、概念的に複雑で文脈依存的な倫理的問題を探索するのに必要な柔軟性を保持できるためとされる。レビューの目標は解釈的 (interpretive) であって集計的 (aggregative) ではなく、したがって量的統合には適さないと明記されている。

3-2. 検索戦略

項目	内容
データベース	Web of Science, PubMed, Scopus, Embase の4件
対象期間	2020年1月～2025年11月
最終検索日	2025年12月3日
検索語	統制語彙 (MeSH など) + フリーテキスト。看護実践、蘇生関連介入 (CPR、DNR 決定、限定的蘇生アプローチ)、臨床ケアの倫理的・道徳的次元を組み合わせ
データベース間の調整	索引構造の違いに応じて各データベース用に検索式を調整
検索式の公開	全データベースの検索式を Supplementary Search Strings ファイルに集約 (再現性のため)

期間を5年に限定した理由は2つ挙げられている。第一に、CPR/DNRの意思決定と moral distress に関する文献量が膨大であり、直近5年に絞ることで最も現代的で代表的なエビデンスの組み入れを担保できること。第二に、2020年以降は臨床コミュニケーション・倫理的熟議・組織力学に重要な変化が起きた時期であり、とくにCOVID-19パンデミックと蘇生方針の変化がCPR/DNR実践を形作ったこと。

3-3. 適格基準

組み入れ基準

- 英語で発表されていること
- 実証研究 (質的・量的・混合法)、または実証的知見を統合した統合的レビュー／ナラティブレビューであること
- 看護師が主たる参加者である、または多職種チームの中で看護の役割・経験・倫理的責任が中心に据えられている文脈での、蘇生の倫理的・道徳的側面を検討していること

- CPR、DNR/DNAR決定、蘇生中止または限定、臨床現場における蘇生関連の意思決定に関する倫理的・道徳的問題に焦点を当てていること

除外基準

- 論説 (editorial)、コメンタリー、学会抄録
- 実証的裏づけのない純粋に理論的な論文
- 蘇生関連の倫理的問題を扱っていないもの

図の解説

紙面の組版上の注意 PDF紙面では、組み入れ基準の4番目(「CPR、DNR/DNAR決定、蘇生中止・限定…に焦点を当てていること」)が **除外基準のブロックに入り込んで印字されている**(組み入れ基準の末尾には行頭の "f" だけが残っている)。文意から、これは組み入れ基準に属するものと読むのが自然である。校正上の瑕疵であり、批判的吟味の項で再度取り上げる。

二次文献の重複計上を避ける手続き(この点は明示的に書かれており、方法論上の美点)

- 統合的／ナラティブレビューが適格と判断された場合、その中で引用されている一次実証研究を特定し、個別に適格基準に照らして評価した
- 各一次実証研究は、複数の二次レビューに引用されていても、統合の目的では**1回だけ**組み入れた
- したがって二次レビューは、関連する実証エビデンスを探し出すことと文脈的・解釈的な枠づけを与えることに用いられ、テーマ統合そのものは基礎となる一次実証研究に基づく

3-4. 研究選択

- タイトル・抄録のスクリーニングは、あらかじめ定めた組み入れ・除外基準に基づき、**第一著者が単独で手作業で実施**
- 潜在的に関連する論文の全文は、**2名のレビュアーが独立に**適格性を評価
- 不一致は討議で解決し、必要時は第3のレビュアーに諮って合意形成
- タイトル・抄録段階で関連性が不確実な論文は暫定的に保持し、全文レビュー段階で評価

3-5. データ抽出

一貫性を担保するため構造化データ抽出フォームを作成。抽出項目は、基本的な出版情報、研究デザイン、セッティング、参加者特性、扱われている蘇生関連の倫理的焦点。

3-6. 質評価

MMAT 2018版を使用。2名のレビュアーが各研究デザインに応じたMMAT基準に従って独立に方法論的厳密性を評価。不一致は討議で解決し、合意に達しない場合は第3のレビュアーに諮った。**個々の研究の質評価結果は Supplementary Table 2 にのみ収載され、本文には示されていない。**

3-7. 分析アプローチ

Braun と Clarke による**反射的テーマ分析**の枠組みに従い、(1) データへの馴染み、(2) 初期コードの生成、(3) 候補テーマの構築、(4) テーマの検討と精緻化、(5) 最終的なテーマ構造の叙述的統合、という手順を踏んだ。初期コードから研究レベルのテーマへの進展と、それらが最終的な7テーマとどう対応するかは Supplementary Table 1 に詳述されている。

分析は解釈的であって集計的ではなく、蘇生関連の看護実践における倫理的経験・意思決定過程・文脈的影響に関する概念的パターンを優先した。プロセスは反復的で、テーマは組み入れ研究から帰納的に発展させつつ、多様な臨床文脈にまたがって報告される倫理概念に感受性を保った。反射性(reflexivity)は、レビュアー自身の職業的・倫理的視点がコーディングと解釈にどう影響しうるかを継続的に省察することで組み込んだ。初期コーディングは2名のレビュアーが独立に実施し、不一致は討議・合意で解決、合意できない場合は第3のレビュアーに諮った。カテゴリのグルーピングと候補テーマはその後、協働的に精緻化した。

3-8. モデル構築の手順

著者らは「本レビューの主目的はモデル構築ではなかった」と明言したうえで、反射的で反復的なテーマ分析の性質により、研究間のパターンが一貫した概念構造に収束したと述べる。7つの最終テーマを踏まえ、テーマ所見をEPMの領域と経路に翻訳する**解釈的マッピング**を行った。

対応づけの層	元になったテーマ	モデル上の位置
ミクロ	個人の情緒的反応、moral distress、看護師の倫理的能力	ベッドサイドの道徳的経験と主体性を捉える層
メソ	チームの階層、権力力学、蘇生チーム内のコミュニケーション	病棟・組織レベルの構造を反映する層
マクロ	法的枠組み、施設方針、より広い文化的・社会的期待	構造的・システムの決定因を表す層

チームでの反復的討議を通じて、これらの層をつなぐ倫理的経路を同定・追跡した。例として、マクロレベルの法的・政策的圧力がメソレベルの組織規範を形作り、それが今度はミクロレベルの看護の道徳的主体性を制約して moral distress に寄与する、という経路が示されている。

そのうえで著者らは繰り返し留保する — EPMは決定的な説明モデルではなく、解釈的で仮説生成的 (interpretive and hypothesis generating) な概念枠組みとして理解されるべきである。

4. 結果 — 組み入れ研究の全体像

図の解説

Figure 1. PRISMA 2020フロー図。左端に縦長のラベル帯 (黄色=Identification/Screening、オレンジ=Included) が並び、中央列に主フロー、右列に除外ボックスが配置される。同定: 4データベースから124件 (PubMed 22件、Scopus 33件、WoS 26件、Embase 43件)。スクリーニング前に重複79件を除外。スクリーニング対象45件のうち12件を除外。全文取り寄せ対象33件、取り寄せ不能0件。適格性評価33件のうち11件を除外 (内訳: moral distress が主概念として扱われていない3件、言語が異なる4件、セッティングが該当しない4件)。最終的にレビューに組み入れ22件。なお図の説明文には「meta-analysis に組み入れた研究の選択」とあるが、本研究はメタ解析ではない (原図・無改変)

4-1. 組み入れ研究の分布と質

22件の実証的・概念的 연구が統合された。地理的分布はアジア・ヨーロッパ・中東・オーストラリア・アフリカ・北米に及ぶ。セッティングはICU、救急外来 (ED)、病院前救急、腫瘍・血液内科病棟、混合病棟を含む。

方法論的には、現象学・グラウンデッドセオリー・テーマ分析・解釈的記述を用いた質的研究、横断調査、ナラティブ分析が含まれる。この方法論的多様性が、蘇生倫理の経験的・態度的・行動的側面を豊かに統合することを可能にしたと著者らは述べる。

質評価はMMAT 2018版で行われ、**全体として質は一定していなかった (variable)**。目的と方法論的アプローチを明確に報告している研究がある一方で、標本サイズが小さい、データ収集・分析手順の報告が不完全といった限界を示す研究もあった。

4-2. Table 1. 組み入れた22研究の特性と倫理的焦点 (原表を日本語化)

No	著者(年)	国	デザイン	セッティング	対象	蘇生に関する倫理的焦点
18	Omoya (2024)	オーストラリア	現象学	救急外来	臨床医 16名	無益にもかかわらず行うCPR、事前指示の欠如、誤解を招く言葉遣い、「板挟み」のスタッフ
19	Stokes (2021)	米国	グラウンデッドセオリー	急性期病院	看護師 15名	限定的蘇生・slow code、象徴的CPR、欺瞞、moral distress、コミュニケーションの失敗
20	Koželj (2024)	スロベニア	質的研究	病院前EMS	正看護師11名	病院前CPRの倫理的ジレンマ：無益なCPR、家族のためのCPR、訓練のためのCPR、DNRの曖昧さ
21	Kang (2021)	韓国	グラウンデッドセオリー	三次病院2施設	臨床医 22名	moral distress：家族によるDNRの上書き、話し合いの遅れ、不適切なCPR、階層、バーンアウト
22	Moghbeli (2025)	イラン	質的テーマ分析	ICU	ICU看護師16名	DNR法が無い状況での slow code：象徴的CPR、法的恐怖、家族の圧力、練習としてのCPR、道徳的離脱

4-3. 横断的に見えたパターン

文脈を越えて反復するパターンが浮かび上がり、蘇生における倫理的複雑さは孤立した個人的要因ではなく、**臨床的不確実性・組織的圧力・法的曖昧さ・文化的期待・関係性の力学の相互作用**によって駆動されていることが明らかになった。

倫理的葛藤が同定されたのは3つの局面である：(1) CPRを開始するか・差し控えるか・中止するか決定、(2) DNR/DNAR指示の解釈と実行、(3) きわめて予後不良な患者の蘇生後ケアの管理。

研究群は一貫して、臨床医が**無益あるいは非有益と信じながらCPRや生命維持治療を継続している**ことを記述していた。同時に、slow code あるいは象徴的蘇生 — 部分的・最小限・意図的に効果の薄いCPR — が繰り返し報告され、とくに法的曖昧さ、家族の圧力、階層的制約を特徴とするセッティングで顕著だった。

横断的な最重要所見は、**看護師・医師・救急隊員に共通する moral distress の遍在**である。自らの倫理的判断や職業的価値観に反する決定の実行を求められたときに生じ、高資源国でも低資源国でも記述された。しばしば、施設の支援の不足、コミュニケーション構造の脆弱さ、家族や上級臨床医からの矛盾する期待によって増幅されていた。

5. テーマ1 — 無益・不適切・象徴的CPR

無益なCPRは研究群を横断して繰り返し報告された。予後不良、不可逆的な悪化、あるいは確立した終末期の軌道にもかかわらず蘇生が開始または継続され、それが一貫して倫理的な居心地の悪さと情緒的負担に結びついていた。

規模を示す定量データ：救急臨床医5099名を対象とした調査(Druwé 2021、24か国288施設)では、**3分の2超が「不適切」と自ら判断するCPRを頻繁に目撃**しており、それは高い moral distress と離職意向に関連していた。

急性期・病院前の記述は、CPRが「やらねばならないから」行われる、あるいは「無意味」と語られるものであり、ときに家族の圧力や法的不確実性に駆動されていた。

反復して現れたパターンが **symbolic / limited / slow-code CPR** — 従っているように見せるため、あるいは葛藤・恐怖・不明確な方針に対処するために用いられる、強度を落とした蘇生である。

CPRはまた、**患者中心でない理由**でも実施されていた：非難を避けるため、施設の期待に応えるため、家族の到着を待つ時間を確保するため。「すでに逝ってしまっている」と知覚された患者に対して、家族との対立や衝突を防ぐために蘇生が行われることもあった。

これらの実践は、法的曖昧さ・組織文化・階層・家族の期待に形作られながら、moral distress と moral residue、そして自らの誠実さが侵食されたという感覚を生み出していた。

△ 注意

slow code は「やさしい妥協」ではない 象徴的蘇生は、現場では **「家族の気持ちに配慮した折衷案」**として正当化されやすい。しかしこのレビューが示すのは、それが **欺瞞(deception)を含み、記録の歪曲につながり、実施した臨床医に moral residue を残す** という帰結である。米国の質的研究(Stokes 2021)は限定的蘇生を「欺瞞」「コミュニケーションの失敗」と明示的に結びつけ、イランのICU研究(Moghbeli 2025)は **DNR法が存在しない状況で slow code が「練習としてのCPR」「道徳的離脱」にまで至る** 過程を記述している。**妥協の産物である象徴的蘇生は、患者の尊厳・臨床医の誠実さ・チームの信頼のすべてを少しずつ削る。**

6. テーマ2 — Moral distress、情緒的負担、moral residue

moral distress は蘇生研究の全体に遍在していた。臨床医が、無益と判断する、あるいは強制されたと感じる、あるいは職業的価値観と矛盾するCPRの提供を余儀なくされたときに生じ、多くは不明確なDNR/DNAR経路と、階層的あるいは家族からの圧力のもとで起きていた。

臨床医が記述したのは、**コード後の強い負担** — 無力感、罪責感、自己不信 — であり、「苦痛を長引かせることで患者を害している」という感覚と、「これ以上の治療が無益なときに自然な死を許さねばならない」という感覚の両方が含まれていた。「無意味な」介入を実施する際に、深い恥辱や霊的な苦悶を報告する者もいた。

量的エビデンスは、不適切と知覚されたCPRを高い moral distress と離職意向に結びつけていた。

セッティングを越えて、**反復した曝露は急性の苦痛を moral residue へと変えた** — 侵入的記憶、後悔、道徳的な汚染感。そして時間の経過とともに **moral erosion (道徳的摩耗)** に至り、slow code、記録の歪曲、密かな治療中止が常態化していった。

苦痛は、脆弱な支援体制(デブリーフィングの制限、倫理コンサルテーションへのアクセスの悪さ)と、高い業務量／支持的でない組織文化によって増幅され、バーンアウト、引きこもり、人材流出に寄与していた。

判断の流れ — moral distress を残滓にしないために

状況	確認すること	次の一手
無益と感じる蘇生を実施した直後	チーム内でその判断が共有されていたか、誰かが違和感を口に出せたか	蘇生後15分以内のホットデブリーフ(臨床の振り返りと感情の言語化を分けて行う)
同じ違和感が繰り返し起きている	個別の症例の問題か、方針決定のプロセスの問題か	プロセスの問題なら症例検討ではなく運用ルールの見直しに上げる
看護師が「言えなかった」と述べた	発言が制度的に保障されているか、単に「言ってよい雰囲気」に頼っていないか	多職種カンファに看護師の発言枠を明示的に設ける
侵入的記憶や後悔が続いている	急性の苦痛ではなく moral residue の段階に入っていないか	個人の耐性の問題として扱わず、倫理コンサルテーションと管理者への報告経路を使う
slow code が「いつものこと」になっている	道徳的摩耗の徴候ではないか	部署単位の問題として扱い、DNAR様式とICのタイミングの構造的見直しを行う

7. テーマ3 — 倫理的曖昧さと不明確な決定経路(DNR/DNAR/ToR/LR)

蘇生を開始・限定・中止することをめぐる倫理的曖昧さは、研究群を横断して遍在していた。脆弱な方針と断片的なコミュニケーションによって形作られた、不明確で一貫性なく解釈されるDNR/DNAR、ToR、LRの指示が、臨床医を「グレーゾーン」での迅速かつ高リスクな判断に追い込んでいた。

スコープをめぐる不確実性(例：DNRが胸骨圧迫のみを対象とするのか、気道管理と薬剤投与も含むのか)は、躊躇、チーム内の不一致、そしてときに象徴的あるいは部分的なCPRを生んだ。

遅れた、あるいは回避された goals-of-care の話し合い(患者を蚊帳の外に置く「沈黙の協定(pacts of silence)」を含む)は、自律をさらに損ない、治療強化から緩和ケアへの急激な転換を強いた。

LR/partial code はとくに曖昧であると繰り返し記述され、ときに困難な終末期の会話の代替物として用いられていた。

同様の曖昧さがToRを取り巻いており、とくに現場の臨床医が中止の権限や標準化された停止基準を持たない場合、蘇生の延長や望まれない努力の継続に寄与していた。

全体として、曖昧さはチームワークと道徳的明晰さを侵食し、非有益なCPR、slow code、対立回避のための治療強化、家族の要求への追従を促進していた。

8. テーマ4 — 階層・権力と制約された看護の道徳的主体性

階層構造と医師支配(medical dominance)は、蘇生における主要な倫理的制約として繰り返し報告された。研究群を通じて、DNR/DNAR、限定的蘇生、終末期計画に対する医師中心の権威が、看護師の道徳的主体性を減じ、倫理的対話を制限し、倫理的に問題のあるCPRに寄与していた。

看護師は、患者を身近に知り、実行の責任を負っているにもかかわらず、蘇生意思決定から排除されていると頻繁に述べた。これが「医師が決め、看護師が従う」という力学を生み、moral distress を強めていた。

階層は強制と恐怖を通じても作動していた：イランと韓国の看護師は、叱責や報復のリスクのために、CPR中に指示に疑問を呈することができなかったと報告した。同様に、若手医師も無益性への懸念を口にしたり終末期の話し合いを始めたりすることで制約されたり罰せられたりしたと感じていた。

これらの圧力は実践を直接形作った — 押しつけられた曖昧な限定的蘇生指示、そして臨床医が無益と判断していてもチームリーダーが主張するために病院前で継続されるCPR。

一部のセッティングでは、貧弱なコミュニケーション風土がさらに発言を抑制し、演技としてのケアや記録の歪曲といった倫理的に妥協した実践を可能にしていた。文化的規範と家族の権威が医師への恭順を強化する文脈では、看護師は決定権を持たないまま情緒的・仲介的な労働を不均衡に担っていた。

全体として、制約された道徳的主体性は一貫して、沈黙化された懸念、役割葛藤、moral distress と residue、離脱、患者アドボカシーの低下につながり、多様なシステムを越えて無益・象徴的・防衛的なCPRのパターンを強化していた。

9. テーマ5 — 家族の影響、文化的・宗教的規範、真実告知の実践

家族の影響と文化的・宗教的規範は、研究群を横断して蘇生の決定を強く形作り、しばしば**臨床判断と患者本人の意向を上書き**していた。

- 臨床医は、CPRが無益と判断される場合であっても、家族の要求を満たすため、努力を示すため、あるいは対立を避けるために、CPRを開始または延長していると頻繁に報告した
- いくつかの文脈では、家族中心の意思決定と予後をめぐる「沈黙」がDNRの話し合いを遅らせ、危機的な心停止に至るまで治療強化を駆動していた
- **家族が記載済みのDNR/DNAR指示を覆すことがあった** — とくに苦情や法的不確実性が恐れられている場合で、臨床医は倫理的に矛盾した実践を強いられていた
- DNRを「見捨てること」と捉える宗教的意味づけが、予期される苦痛にもかかわらず完全な蘇生を求める要請をさらに強めていた
- **コミュニケーションの枠づけ(framing)も重要だった**：曖昧な、あるいは情緒的に負荷のかかった問いかけは家族を「できることは全部やってください」の方向へ押しやり、遅れた会話は家族を準備のない状態に置き、終末期でのCPRへの圧力を高めていた

著者らはこのテーマを次のように総括する — これらの力は関係的・文化的・構造的なレベルで作動し、しばしば臨床判断・患者の意向・倫理原則よりも強くCPR/DNRの経路に影響した。ほぼすべての組み入れ研究にわたって、**家族が — 患者でも臨床医でもなく — 蘇生の決定の最終的な裁定者になっている**という複雑な倫理的風景が浮かび上がった。

この点は、ICUの対立を課題・プロセス・関係の3層で読み解く — 「困った家族」の多くはプロセス不全の帰結 (ナラティブレビュー・CritCare2026) と正面から響き合う。家族が「上書きする」ように見える現象の多くは、家族の性質ではなく、遅れた説明・曖昧な問いかけ・準備不足という**プロセスの帰結**として記述されている。

10. テーマ6 — システム・法・組織が駆動する非倫理の実践

蘇生における倫理的問題は、一貫して**個人的なものではなくシステムのもの**として記述された。研究群を通じて、法的曖昧さ・組織文化・資源制約が、倫理的に適切なCPRの決定を実行しにくくし、無益・象徴的・防衛的な蘇生と脆弱な終末期コミュニケーションを日常的に生み出していた。

駆動因	具体的な機序	帰結
法的地位の不明確さ	DNR/DNARと蘇生の中止に対する法的保護が限定的	苦情や訴追への恐怖から「防衛的CPR (defensive CPR)」が生じる。方針が存在せず非公式な指示が標準化された経路の代わりを務める場では特に顕著
組織風土	倫理的議論を歓迎しない、階層に依存する、近道(記録の操作を含む)を黙認する	倫理的に妥協した実践と moral distress を強化
混雑・人員不足	緩和ケアの能力が限られている	既定値としての治療強化と、危機駆動型の心停止を招く
病院前システム	ToRの権限やプロトコルが無い	望まれない努力を長引かせ、搬送を強制する
実績・記録の圧力	可視的な介入が評価される構造	適切性にかかわらず介入することにインセンティブが生じる
倫理支援の不在	デブリーフィング・コンサルテーション・法的助言が無い	臨床医は回避や象徴的CPRで対処するしかなくなる

著者らの総括は明快である — 問題のあるCPRのパターンは、**法的・組織的システムに埋め込まれた構造的な倫理の失敗を反映している**のであって、**臨床医の道徳的欠陥ではない**(not clinician moral deficit)。

11. テーマ7 — 倫理的能力、道徳的感受性、アドボカシー、倫理支援

倫理的能力(道徳的感受性、方針の知識、コミュニケーション、アドボカシー)と倫理支援の利用可能性は、複雑な蘇生状況への臨床医の反応を強く形作っていた。

- **道徳的感受性**は、無益性・苦痛・価値と不一致なCPRを検知するのを助けたが、その懸念が却下されたときには、しばしば moral distress と消耗を強めた
- **訓練のギャップ**とDNR/DNARの理解不足は不確実性と不安を高め、逆に倫理的・方針的な能力が強い場合には自信と患者中心の意思決定が改善した
- **患者の価値観のためのアドボカシー**は繰り返し不可欠と記述されたが、同時にリスクを伴うものだった。協働的なチームでは最も強く発揮されたが、階層と家族の反対によって制約されることが多く、一部の臨床医は撤退・対決の回避に向かい moral residue を蓄積させた
- **公式の倫理支援**(倫理コンサルテーション、デブリーフィング、症例レビュー、研修)は、しばしば不在かアクセス困難であり、臨床医は外傷的なコードのあとに孤立していた。存在する場合には、これらの支援は苦痛を

減らし、学習とチームの結束を強めていた

- 支援の欠如が長引くことは道徳的摩耗と結びつき、slow code・演技としてのケア・密かな治療中止の常態化を招いた

全体として、倫理的能力と支援は「**倫理的安全(ethical safety)**」の機構として機能していた — 弱ければ妥協したCPRと臨床医の傷つきが起こりやすくなり、強ければ価値と一致したケアとアドボカシーが達成しやすくなる。

12. 考察 — 生命倫理の四原則との対応づけ

著者らは所見を、孤立したベッドサイドのジレンマではなく、四原則にまたがるシステムの緊張として読み解く。

原則	このレビューで何が侵食されていたか	侵食の機序
自律尊重(autonomy)	DNR/DNAR経路の持続的な曖昧さ	本人の意向が知られない、うまく伝わらない、あるいは家族・施設によって上書きされる。終末期の話し合いが遅れることが危機駆動型の介入を促進する
善行(beneficence)	反復する無益あるいは象徴的なCPR	意味のある利益をもたらさずに苦痛を長引かせる
無危害(nonmaleficence)	同上	倫理学的分析は「臨床医は非有益な治療を提供する義務を負わない」と論じるが、法的リスク・組織文化・階層がこれらの実践を維持し続けている
正義(justice、とくに分配的正義)	混雑・資源制約・脆弱な緩和ケア経路	CPRの過剰使用と不十分な終末期ケアを駆動する。代替手段が利用できないときに既定値としての積極的介入が生じる、という構造的不平等の分析と一致

先行文献との関係(著者らが自ら位置づけている点)

- DNR/DNARの曖昧さの顕著さは、一貫性のない方針が患者中心の決定を損ない望まれないCPRに寄与するという長年の懸念を反映する。地域間の変動は、より明確で統一されたガイダンスを求める繰り返しの呼びかけを生んできた
- 本データセットは、無益なCPRと象徴的／slow code(「儀礼的(ceremonial)」)蘇生の世界的報告を反映しており、それらが訴訟への恐れ・文化的期待・施設規範に形作られていることから、孤立した臨床医の行動というより**未解決の倫理的・コミュニケーション上の緊張に対する構造的反応**であることを示唆する

- moral distress の所見は集中治療・腫瘍・救急医学の堅固なエビデンスと一致するが、本レビューが加えるのは、**反復する曖昧さ・階層・家族駆動のCPRのもとで、苦痛から moral residue／離脱へと至る軌道をより明確に描いた点**である
- 家族の影響も先行研究と一致するが、本レビューは**家族の意向が患者の意思や記載済みのDNR指示を上書きする事例をより明示的に記録**しており、さらなる研究を要する倫理的に妥協した経路を示している

13. Ethical Pathways Model (EPM) — 構成要素の全体像

図の解説

Figure 2. Ethical Pathways Model (EPM) — 蘇生意思決定モデル。左側に灰色の縦3ボックス（上からMacro Level / Meso Level / Micro Level）が縦の点線双方向矢印でつながれ、それぞれから太い実線矢印が中央の白い四角「Proportionality of Care (下向き矢印) CPR/DNR Decision Point」に収束する。中央の決断点からは2本の矢印が出る — 上向きの緑の矢印が緑ボックス「Ethically Aligned Pathway」へ、下向きの赤い矢印が赤ボックス「Ethically Conflicted Pathway」へ。赤の葛藤経路からは、上向きの緑矢印で緑ボックス「Adaptive Responses」へ向かう分岐と、下向きの赤矢印で赤ボックス「Maladaptive Outcomes」へ向かう分岐の2つが出る。右側には青ボックスが2つ縦に並び、上が「Positive Outcomes」、下が「Negative Outcomes」。緑の整合経路と Adaptive Responses は緑の矢印で Positive Outcomes へ、Maladaptive Outcomes は赤の矢印で Negative Outcomes へ入る。両アウトカムボックスの右端からは、図の外周をまわる長い点線が左端に戻り、3つの決定因ボックスすべてに再入する（強化フィードバックループ）。左下に凡例ボックス（実線矢印＝直接的影響／点線矢印＝強化フィードバックループ／緑ボックス＝倫理的に整合したプロセス／赤ボックス＝倫理的に葛藤したプロセス／青ボックス＝アウトカム）（原図・無改変）

13-1. モデルの全構成要素と、蘇生現場での具体例

原図の各ボックスに書かれた文言をすべて表に起こし、それぞれが実際の蘇生現場のどの場面に当たるかを併記する。

層／要素	原図の記載(構成要素)	蘇生現場での具体例
マクロ:構造的決定因	Legal ambiguity(法的曖昧さ)	治療の中止に刑事免責の明文規定が無いため、「やめる」判断に誰も署名しただらない
マクロ:構造的決定因	Resource constraints(資源制約)	ICU満床・夜間人員が薄い・緩和ケアチームが平日日中のみ、という条件で「とりあえずフルコード」が既定値になる
マクロ:構造的決定因	Cultural norms(文化的規範)	予後を本人に直接伝えないことが「思いやり」とされ、本人不在で方針が決まる
マクロ:構造的決定因	Institutional policies(施設方針)	DNAR様式にスコープの記載欄が無く、指示の意味が部署ごとに違う
メソ:関係的決定因	Family expectations(家族の期待)	「できることは全部お願いします」の一言で、記載済みの方針が事実上停止する
メソ:関係的決定因	Team hierarchy(チーム階層)	コードリーダーが継続を指示している間、誰も「そろそろ」と言い出せない
メソ:関係的決定因	Communication(コミュニケーション)	方針が申し送りではなく口頭の言い回しだけで伝わり、夜勤帯で解釈がずれる
メソ:関係的決定因	Shared decision making(共同意思決定)	家族面談が「同意を取る場」になっていて、価値観を聴く場になっていない
ミクロ:個人的決定因	Moral sensitivity(道徳的感受性)	「この蘇生はおかしい」と気づける力。気づいても言えないと苦痛だけが残る
ミクロ:個人的決定因	Ethical competence(倫理的能力)	DNARのスコープ、代理判断の原則、無益性の議論を言語化できるか
ミクロ:個人的決定因	Burnout(バーンアウト)	消耗しているほど、違和感を飲み込んで流す方向に傾く

層／要素	原図の記載(構成要素)	蘇生現場での具体例
ミクロ:個人的決定 因	Personal values(個人の価値観)	「最期まで諦めない」という個人の信条が、 患者の価値観と混線する
中心:決断 点	Proportionality of Care → CPR/DNR Decision Point(ケアの相応性→CPR/DNRの 決断点)	心停止の瞬間、あるいはその手前の「どこま でやるか」を決める瞬間。3層の力がここに 収束する
経路A(緑)	Ethically Aligned Pathway: Value- concordant decision-making, Shared decision making (Clarity, advocacy, debriefing, patient-centred care)	本人の価値観が事前に共有されており、チ ームの理解が一致し、明確さ・アドボカシ ー・デブリーフィング・患者中心のケアが伴 う経路
経路B(赤)	Ethically Conflicted Pathway: Constrained agency & moral distress (Ambiguity, Constrained agency, Moral distress)	曖昧さ、制約された主体性、moral distress を特徴とする経路
経路Bから の分岐 (緑)	Adaptive Responses: Advocacy, Ethics consultation, debriefing, support (適応的 反応)	葛藤に対してアドボカシー・倫理コンサル ト・デブリーフィング・支援で応じる。ここを 通れば陽性アウトカムに合流できる
経路Bから の分岐 (赤)	Maladaptive Outcomes: Symbolic CPR, defensive resuscitation, disengagement, emotional exhaustion (不適応な帰結)	象徴的CPR、防衛的蘇生、離脱、情緒的消 耗
アウトカム (青・陽性)	Value-concordant care, Patient dignity, Professional integrity, Trust preservation	価値と一致したケア、患者の尊厳、職業的 誠実さ、信頼の保持
アウトカム (青・陰性)	Patient suffering, Clinician burnout, Moral residue, System erosion	患者の苦痛、臨床医のバーンアウト、moral residue、システムの侵食
フィードバ ック	点線=Reinforcing feedback loop(強化フィ ードバックループ)	アウトカムがマクロ・メソ・ミクロの3層すべ てに戻り、規範と組織の期待を強化あるい は再形成する。悪い経路は次の症例をさら に悪くする

13-2. モデルが主張する因果の向き

著者らが本文で明示している経路は次のとおり。

- **マクロ → メソ → ミクロ**:マクロレベルの法的・政策的圧力がメソレベルの組織規範を形作り、それがミクロレベルの看護の道徳的主体性を制約し、moral distress に寄与する
- **3層 → 決断点**:構造的・関係的・個人的な因子が「ケアの相応性」の決断点に収束する
- **決断点 → 2経路**:明確さと共有理解があれば整合経路へ、曖昧さ・不一致・制約された主体性が支配すれば葛藤経路へ
- **葛藤経路 → 2分岐**:moral distress を経験した臨床医は、適応的な倫理的反応(アドボカシー、コンサルテーション、デブリーフィング)へ向かうことも、不適応な行動(象徴的CPR、防衛的蘇生、記録の操作、道徳的離脱)へ向かうこともある
- **アウトカム → システムへの還流**:倫理的に妥協した経路は、患者の苦痛と不一致なケアだけでなく、臨床医のバーンアウト、moral residue、職業的誠実さの長期的侵食をもたらす。これらの帰結はより広いシステムへとフィードバックし、規範的・組織的期待を強化あるいは再形成する

13-3. 著者自身による位置づけ

著者らは、EPMが「moral distress や意思決定の自律性といった孤立した構成要素に焦点を当ててきた既存の枠組みとは異なり、構造的・関係的・心理的次元を統一的な概念構造に統合する」点で理解を前進させると主張する。同時に、次の留保を**同じ段落で2度繰り返している** — EPMは決定的な説明モデルではなく、解釈的で仮説生成的な概念枠組みとして理解されるべきであり、将来の実証的探究の概念的基盤を提供するにとどまる。

14. 実践・政策・教育への含意(著者らの提案)

レベル	提案されている内容
臨床	危機駆動型の決定ではなく、goals of care についての早期かつ構造化されたコミュニケーションを行う。それによりDNR/DNAR状態をめぐる曖昧さを減らし、望まれないCPRや象徴的CPRを防ぐ。多職種での議論と一貫した記録を急性期・集中治療のルーチンにする。ベッドサイドでの中心的役割を踏まえ、看護師の道徳的主体性を強化し、蘇生の意思決定への関与を明確にする
組織	DNR、DNAR、蘇生の中止について、明確でアクセスしやすい方針を整備する。倫理的に複雑な蘇生の場面を切り抜け moral distress を緩和するための実務的な支援機構（迅速な倫理コンサルテーション、構造化デブリーフィング）を設ける
教育	倫理的能力・コミュニケーション技能・地域の法的枠組みの理解を強化する。症例ベースの議論とシミュレーションを取り入れた訓練により、曖昧さ・家族の圧力・階層的制約に自信を持って対処できるようにする
政策	施設方針と国の法制度の整合を図り、臨床医が法的・組織的な報復を恐れずに倫理的に妥当で患者中心の蘇生を提供できるようにする

15. 日本の文脈に置き換えて読む

このレビューはイラン・トルコ・パキスタン・韓国など、DNR/DNARの法的位置づけが不明確な地域の記述が理論の骨格に強く効いている。日本の文脈に置き換えると、**重なる部分**と**明確に異なる部分**の両方が見えてくる。

論点	本レビューが描く状況	日本の文脈
法的枠組み	DNR/ToRに法的保護が乏しい国では防衛的CPRが生じる	日本にも生命維持治療の中止に関する明文の刑事免責規定は無い。厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(2007年策定・2018年改訂でACPの考え方を導入)と、日本救急医学会ほか3学会「救急・集中治療における終末期医療に関するガイドライン」(2014年)が抛りどころだが、これらはガイドラインであって法律ではない。 「法的曖昧さ→防衛的CPR」という本レビューの機序は、日本にもそのまま当てはまる
DNARのスコープ	DNRが胸骨圧迫のみか、気道・薬剤も含むかで現場が割れる	日本救急医学会は用語統一の中で「DNAR指示が有効なのは心停止時のみ」と明示している。それでも現場では「DNAR＝ICU入室不可・挿管不可・昇圧薬不可」と拡大解釈される場面が残る。 本レビューの主要テーマがそのまま日本の課題である
医師指示書の制度	米国のPOLST型文書がある地域とない地域が混在	日本にはPOLSTに相当する法的裏づけを持つ医師指示書の制度が無い。日本臨床倫理学会の「日本版POLST(DNAR指示を含む)」提言(2015年)はあるが、法制化されておらず普及も限定的。 したがって「文書が意向を守る」という前提はより弱い
代理意思決定	家族が本人の意向を上書きする事例が多く、文脈で報告	日本では法定の代理決定者制度が無く、「家族等」が事実上の意思決定者となる運用が広く行われている。 本レビューが問題視する「家族が最終的な裁定者になる」構図は、日本では例外ではなく標準の運用形態に近い
真実告知	「沈黙の協定」で患者本人が蚊帳の外に置かれる	日本でも予後の説明が家族先行で行われ、本人には伝えられないまま方針が決まる場面が残る。本レビューの「pacts of silence」は日本の臨床にも直接対応する概念である
家族の立ち会い	家族の到着を待つためのCPR、家族のためのCPRが報告	日本のICU・救急でも、家族の到着まで蘇生を続ける判断はしばしば行われる。本レビューはこれを「患者中心でない理由によるCPR」として明確に分類しており、その視点は日本の現場では明示化されていないことが多い
無益性の判断	「臨床医は非有益な治療を提供する義務を負わない」とする倫理学的原則が、法的リスクと組織文化で無効化される	日本では無益性を理由とした一方的な治療中止の法的位置づけがさらに不明確であり、この無効化はより強く働きうる

論点	本レビューが描く状況	日本の文脈
資源配分	混雑・人員不足・緩和ケア体制の弱さが治療強化を既定値にする	日本のICUでも、緩和ケアチームの稼働時間や退室先の確保が方針決定に事実上影響する。本レビューはこれを分配的正義の問題として明示的に位置づけている

△ 注意

「DNAR」の一語で会話を終わらせない このレビューの中で日本から採択された唯一の研究(Tanabe 2023、院外心停止の多施設横断研究)の倫理的焦点は、**DNARの誤解釈、slow code、家族との対立と法的不確実性によるストレス** である。つまり **日本の現場でも、DNARという言葉が指す範囲がチーム内で一致していないことが、すでに実証的に記述されている**。DNAR指示は「心停止時に蘇生を試みない」という一点のみを意味し、それ以外の治療をどこまで行うかは別途の合意が要る。この区別を診療録の様式そのものに埋め込まない限り、**個人の努力や口頭での申し送りでは曖昧さは解消しない**。

16. 強みと限界(著者らの記載のまま)

強み

- 主たる強みは、地域・医療システム・臨床セッティングを横断する **22研究のグローバルに多様なエビデンス基盤** であること。この広がり転用可能性(transferability)を支え、蘇生の倫理的意決定に関する多層モデルの構築に情報を与えた
- 反射的テーマ分析の使用により、システム・関係・個人の因子がどう相互作用してCPRとDNRの決定における倫理的帰結を形作るかを説明する新しい概念モデル(EPM)を生成する解釈的統合が可能になった

限界

- **ナラティブ(非系統的)デザイン**であり、出版バイアスまたは選択バイアスのリスクを高める
- 方法・文脈・掲載媒体の**異質性**が、研究間の直接的な比較可能性を制限する
- すべての組み入れ研究が適格基準を満たし質評価を受けたものの、**報告水準と方法論的厳密性のばらつき**が、特定のテーマを支えるエビデンスの強さに影響しうる
- **質的研究の優位**が、文脈的洞察の深さにもかかわらず一般化可能性を制限しうる
- **モデルは文献由来であって前向きに検証されていないため**、特定の臨床セッティングでの実証的検証が必要である

17. 今後の研究の方向性(著者らの提案)

- EPMの各側面を実証的に検討する方法を探索する。とくに混合法または縦断デザインにより、文脈的・組織的・関係的因子がリアルタイムの蘇生意思決定の最中にどう相互作用するかを調べる
- 異文化間研究により、法的枠組み・コミュニケーション規範・家族力学が多様な医療システムを越えて倫理的経路をどう形作るかをさらに解明する
- 倫理教育、構造化されたコミュニケーション訓練、施設的倫理支援(迅速な倫理コンサルテーション、構造化されたチームデブリーフィングなど)といった介入が、臨床医の moral distress の経験と価値に一致したケアの提供に影響するかを検討する
- 急性期・集中治療において象徴的あるいは非有益なCPR実践を減らす方略を同定する実証研究

18. 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

18-1. ナラティブレビューであることに由来する選択バイアス

- **検索の収量が異様に少ない。**5年間・4データベースで同定されたのは124件のみ(PubMed 22件、Scopus 33件、WoS 26件、Embase 43件)。CPR・DNR・moral distress という広いテーマに対してこの数は小さく、検索式が狭かった可能性を示唆する。検索式は Supplementary にのみ収載され本文には無いため、読者は再現性を本文だけでは確認できない
- **タイトル・抄録スクリーニングが第一著者の単独作業である。**二重スクリーニングは全文段階からで、最も多くの論文が落ちる段階が単独判断になっている
- **言語制限:**英語のみ。除外理由の内訳でも「言語が異なる」が4件。日本語・ペルシャ語・韓国語など、まさに本レビューが論じる文化的文脈を記述した文献が構造的に落ちている
- **地理的な偏り:**22研究のうちイランが5件(No.3, 9, 10, 14, 22)と最多。著者らもイランの機関に所属する。「DNR法が存在しない」文脈の記述が、テーマ1(象徴的CPR)とテーマ6(法的曖昧さ)の骨格を強く規定している可能性がある。「グローバルに多様」という強みの主張は、件数の分布を見ると割り引いて読むべきである
- **看護中心の適格基準:**組み入れ基準が「看護師が主たる参加者、または看護の役割が中心」であるため、テーマ4(階層・看護の道徳的主体性)が前景化するのとは半ば設計上の帰結である。医師や救急隊員の視点から見た同じ現象の重みづけは異なりうる

18-2. 方法の記述と実際の齟齬

- **二次レビューの扱いに内的矛盾がある。**方法では「二次レビューは一次実証研究を探し出すために用い、テーマ統合は一次実証研究に基づく」と述べ、除外基準では「実証的裏づけのない純粋に理論的な論文」を除くとしている。ところが Table 1 の22研究には、Susanti 2024(Literature review・15研究を対象)と

Kumar 2023 (Narrative ethical review・対象者の記載なし)という二次文献2件がそのまま組み入れ研究として計上されている。22という数字の内訳は方法の記述と一致していない

- **Table 1 の対象者記載が欠けている行が多い。**No.6(看護師・医師)、No.7(臨床医)、No.8(看護師)、No.9(クリティカルケア看護師)、No.10(看護師)は人数の記載が無く、No.12 と No.17 は「-」。統合の重みづけを読者が判断できない
- **質評価の結果が本文に無い。**MMATの結果は Supplementary Table 2 のみ。「質は一定していなかった (variable)」と述べるだけで、質の低い研究がどのテーマを支えていたかが分からない。感度分析も無い
- **Figure 1 のキャプションが「meta-analysis」となっている。**本研究はメタ解析ではない。PRISMAテンプレートをそのまま流用した校正漏れである
- **抄録のMethodsに文が途切れた箇所がある** ("Eligible studies included." で終わる)。また本文の組み入れ／除外基準のリストは、組み入れ基準の1項目が除外基準ブロックに紛れ込んで印字されている。**方法の中核部分に校正上の瑕疵が複数ある**という事実は、査読・編集過程の厚みを推し量る材料になる

18-3. モデルの検証可能性

△ 注意

EPMは「地図」であって「証拠」ではない EPMは **22研究のテーマ分析から解釈的に構築されたものであり、同じデータから作られたモデルを同じデータで検証することはできない**。著者ら自身が「解釈的で仮説生成的な概念枠組みであって決定的な説明モデルではない」と本文中で少なくとも3回繰り返している。ジャーナルクラブでの論点は次の3つになる。**(1) このモデルは反証可能か — どの観察が得られればモデルが誤りだと言えるのか。(2) 4領域(構造・関係・個人・決断点)と2経路という区分は、既存の社会生態学モデルやJameton/Epstein & Hamric の moral distress 理論に何を付け加えたのか。(3) 「マクロ→メソ→ミクロ→帰結→フィードバック」という因果の向きは、横断的・質的なデータから本当に導けるのか**(多くは同時に観察されたものであり、時間的先行関係は示されていない)。**モデルの「説明力」は、現時点では記述の整理としての説得力であって、予測力ではない。**

18-4. 法域・文化への依存性

- モデルの中心概念である「proportionality of care(ケアの相応性)」は、どの文化圏でも同じ内容を指すわけではない。何が「相応」かは、本人の自律をどこまで優先するか、家族の役割をどう位置づけるかによって変わる
- 「家族が最終的な裁定者になっている」ことを本レビューは倫理的に問題のある帰結として扱うが、家族中心の意思決定を規範とする文化圏では、それ自体が本人の価値観に沿った形でありうる。**このモデルは自律尊重を基軸に置く西欧的な生命倫理の枠組みを暗黙の基準としている**という指摘は成り立つ

- 「法的曖昧さ→防衛的CPR」という機序は強く支持されるが、逆に「明確な法があれば良い実践になる」ことは本レビューからは言えない。韓国の Well-dying法のように法制化後の変化を検証した研究([Well-dying法とICUにおける死の質の変化\(韓国 ICM2021\)](#))と突き合わせて議論する価値がある

18-5. ジャーナルクラブで投げたい問い

- 当院のDNAR様式は、「心停止時のみ」というスコープを紙面上で強制できているか。できていないなら、それはこのレビューが言う「institutional policies」というマクロ決定因の問題である
- 我々の病棟で slow code に相当する実践は起きていないと言い切れるか。起きているとしたら、それは誰の道徳的欠陥ではなく、どの構造の産物か
- 家族の到着を待つための蘇生継続を、我々は「思いやり」と呼ぶか「患者中心でないCPR」と呼ぶか。両方が真でありうるとして、その判断は誰が、いつ、どう記録するのか
- 蘇生後のデブリーフィングを制度として持っていないとすれば、moral residue の蓄積を我々は個人の耐性に任せていることになる。それでよいのか

19. 主要な引用文献一覧

内容	著者・雑誌・年
生命倫理の四原則の原典	Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics(本論文の考察の枠組み)
ICU終末期ケアの推奨(ACCM コンセンサス)	Truog RD, et al. Crit Care Med 2008;36(3):953–63
蘇生における倫理的課題の総説	Mentzelopoulos SD, et al. Intensive Care Med 2018;44(6):703–16
moral distress の原概念	Jameton A. Nursing Practice: The Ethical Issues, 1984/ AMA J Ethics 2017;19(6):617–28
moral residue とクレッシェンド効果	Epstein EG, Hamric AB. J Clin Ethics 2009;20(4):330–42
構造的暴力の人類学(正義の議論の下敷き)	Farmer P. Curr Anthropol 2004;45(3):305–25
ケアリングを道徳的経験として捉える	Kleinman A. Lancet 2012;380(9853):1550–1
世界のICU終末期実践の変動(Ethicus-2)	Avidan A, et al. Lancet Respir Med 2021;9(10):1101–10
DNR指示の世界的な見取り図	Santonocito C, et al. J Crit Care 2013;28(1):14–21
院内DNR指示はなぜ失敗したか・どう直すか	Yuen JK, et al. J Gen Intern Med 2011;26(7):791–7
アジアのICUにおける生命維持治療の差し控え・中止	Phua J, et al. JAMA Intern Med 2015;175(3):363–71
コードステータス様式の設計の施設間変動	Batten JN, et al. BMJ Qual Saf 2021;30(8):668–77
院内心停止におけるCPRの無益性(系統的レビュー・メタ解析)	Beck K, et al. Resuscitation 2022;172:181–93
象徴的蘇生・医学的無益性・親の権利	Frader J, Kodish E, Lantos JD. Pediatrics 2010;126(4):769–72
純粋に演技としての蘇生 — 患者をモノとして扱うこと	Tarasenko-Struc A. Bioethics 2025;39(4):343–9

内容	著者・雑誌・年
slow code は特異的に欺瞞的か	Grosso MB, Nicolas P. Bioethics 2025;39(4):350–8
不適切なCPRと離職意向(本レビュー最大のn)	Druwé P, et al. Resuscitation 2021;158:41–8(24か国288施設・5099名)
日本の院外心停止・DNAR指示下の治療パターンと臨床医のストレス	Tanabe R, et al. Resusc Plus 2023;16
限定的蘇生のグレーゾーン(米国)	Stokes F, Zoucha R. AJOB Empir Bioeth 2021;12(4):239–52
DNR法が無い状況での slow code(イラン)	Moghbeli(2025、本レビュー Table 1 No.22)
韓国の終末期患者ケアと医師・看護師の moral distress	Kang J, et al. PLoS One 2021;16(12):e0260343
「板挟み」— 救急の医師・看護師の終末期倫理的ジレンマ	Omoya OT, et al. Int Emerg Nurs 2024;77:101535
蘇生後ケアの倫理的・法的問題(記録の改ざん・密かな差し控え)	Zali M, et al. Nurs Ethics 2023;30(2):245–57
CPRにおける看護師のアドボカシー役割	Tíscar-González V, et al. Nurs Ethics 2020;27(2):333–47
DNR決定の倫理(腫瘍・血液内科)	Pettersson M, et al. BMC Med Ethics 2020;21(1):66
部署文化とCPR関連 moral distress	Weill-Lotan D, et al. Heart Lung 2024;68:254–9
CPR中の道徳的感受性(質的)	Aghakhani N, et al. Nurs Ethics 2022;29(4):938–51
蘇生の中止とDNR指示に対する知識・態度・意思決定	Goodarzi A, et al. Ethiop J Health Sci 2022;32(2):413–22
文化と個人がCPRに与える影響(国際調査)	Ozer J, et al. BMC Med Ethics 2019;20(1):102
蘇生時の家族立ち会いをめぐる意思決定	Giles T, et al. J Adv Nurs 2016;72
反射的テーマ分析の方法論	Braun V, Clarke V(本論文の分析枠組み)

✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- 蘇生をめぐる倫理的問題の大半は、臨床医個人の道徳的欠陥ではなく、法的曖昧さ・組織文化・階層・資源制約が生み出す構造的な産物である。「もっと倫理的に考えよう」という呼びかけでは動かない
- DNAR指示のスコープが紙の上で定義されていない限り、現場の解釈は必ずばらつく。日本の現場でも「DNAR＝心停止時のみ」という原則が拡大解釈されている実態が実証的に記述されており、**様式そのものを直すことが最も費用対効果の高い介入である**
- slow code・象徴的CPRは「家族への配慮」ではなく、欺瞞・記録の歪曲・moral residue を生む妥協である。起きているなら、個人を責めずに **どの構造がそれを生んでいるかを問う**
- moral distress を moral residue に変えないための最も安価な仕組みは、蘇生後の構造化デブリーフィングと、アクセスしやすい倫理コンサルテーションの2つ。このレビューはその効果を証明してはいないが、支援が「不在である」ことの害は一貫して記述されている
- EPMは「問題の地図」であって「効果の証拠」ではない。著者ら自身が仮説生成的な枠組みだと繰り返し留保している。導入の根拠として使うのではなく、**当院の蘇生の意思決定のどこが詰まっているかを可視化する道具として使うのが正しい使い方である**

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。